

Affections liées à la chaleur

Dans tous les cas

- réaliser un refroidissement passif de la victime

La victime présente une détresse vitale

- appliquer la conduite à tenir adaptée.

La victime ne présente pas de détresse vitale

- installer la victime dans une position **d'attente** ;
- réhydrater la victime avec de l'eau ou mieux un liquide contenant des glucides et des sels minéraux tels que jus de fruits (sauf si la victime présente des vomissements).

Crampe

- refroidir éventuellement avec l'application de glace ;
- compléter l'action de secours par :
 - des étirements doux,
 - des massages musculaires.
- indiquer à la victime de ne pas reprendre l'activité avant l'arrêt complet des signes.

Insolation

- réaliser un **refroidissement actif simple** de la victime en fonction des moyens disponibles ;
- poursuivre le bilan et surveiller attentivement.

Coup de chaleur et hyperthermie maligne d'effort

- réaliser un **refroidissement actif avancé**¹ de la victime ;
- poursuivre le bilan et surveiller attentivement :
 - l'évolution des signes de détresse vitale,
 - la température corporelle.
- transmettre le bilan pour avis² sans délai ;

Le refroidissement actif doit se poursuivre jusqu'à la disparition des signes neurologiques et jusqu'à ce que la température corporelle de la victime devienne inférieure à 39°C ou pendant 15 minutes si la température ne peut être mesurée.

Un bilan complet est nécessaire avant³ toute verticalisation ou mobilisation de la victime après l'immersion.

¹ Mettre tout en œuvre pour obtenir les moyens de réaliser un refroidissement actif.

² Présenter tous les signes de gravité et appliquer les consignes reçues. Une prise en charge médicale d'urgence est nécessaire.

³ Les victimes peuvent présenter une hypotension (notamment à cause de la déshydratation) qui sera aggravée à l'orthostatisme pouvant aller jusqu'à entraîner un désamorçage cardiaque.